

Хигијена и нега новорођенчета

Припрема собе за бебу, намештаја и опреме за бебу

Пожељно је да бебина соба буде нежних пастелних боја светла, уредна и без непотребних ствари које скупљају прашину и отежавају одржавање хигијене у соби. На зидовима ти требало да буде неки шарени детаљ, тапетна бордура са дечијим мотивима, стикери за зид са цртаним ликовима. Креветац или колевка се у зависности од величине просторије може налазити у родитељској спаваћој соби, а беба може имати одвојену собу. Креветац или колевка би требало да испуњавају безбедносне стандарде. Препорука је да душек за бебу буде чврст и у првим данима подигнут на највиши ниво у кревету, да се мама не би савијала преко странице. Идеално место за креветац је у углу собе где нема директног излагања сунцу. Довољно одвојен од прозора, да приликом проветравања беба не буде на директном струјању ваздуха. Креветац би требало померити минимум 1-1.5 метар од извора топлоте, као и од струјних утичница. Приликом одабира постељине за креветац бирајте оне од природних материјала, такође не би требало затварати оградом све четири странице кревета јер је беби неопходан доток ваздуха. Комодица за бебину гардеробу, може послужити и као простор за повијање бебе, ако се на њу постави мекана повијалица. Све потребне ситнице за негу бебе нека вам буду на дохват руке заштитне креме, пелене, гардероба. Лагана, нежна, тиха музика у бебиној близини делује стимулативно на бебина чула, а пригушено светло помоћи ће вама да се оријентишете приликом честог ноћног устајања. Кутак за дојење, је удобана фотеља или кревет где можете да се опустите и у миру посветите храњењу бебе. Пожељно је да то буде у бебиној или вашој заједничкој соби. Температура у соби би требало да буде од 18 до 23С, а када се беба купа од 26 до 28С. Собу треба редовно чистити и проветравати, а зими загрејани ваздух треба влажити.

Купање бебе

У првих 14 дана по рођењу препоручује се купање 2 – 3 пута недељно по 5 минута, искључиво чистом топлом водом без коришћења сапуна и купки. Сушење коже урадити тапкањем, а не грубим брисањем или трљањем.

Код промене пелена када се беба упишки, довољно је кожу пребрисати блазницама вате натопљене топлом водом. Када беба има столицу одстранити садржај блазницама вате и добро испрати топлом водом, нарочито превоје. Треба имати на уму да се у наборима гениталне регије може завући нечистоћа и то може бити разлог кожных и мокраћних инфекција (код девојчица раширити велике усне и опрати водом, а код дечака померити кожицу гланса пениса до границе покретљивости и опрати). Када беба има столицу, није пожељно брисати столицу тоалет папиром или сувом тетра пеленом, грубо брисање може повредити бебину кожу. У периоду одојчета па до годину дана старости бебе наставља се пребрисавање свако вече, а

купање 2-3 пута недељно до 10 минута.Пре купања проветрити па загрејати на 24-26 степени просторију где се беба купа,, затим опрати кадицу и руке пре купања бебе.Температура воде треба да буде од 35 до 37 степени, проверава се топломером за воду.Пре купања треба припремити,кадицу, пешкир са капуљачом, рукавицу за купање, сапун или купку, бокал за поливање, гардеробица за облачење бебе, хидрантна крема за пеленску регију, сет за ноктиће, четка и чешаљ, стерилне компресе, физиолошки раствор, лосион или крему за тело.Беба се може купати на два начина, преко руке, обично у првих месец дана или тако што лежи у кадици.

Купање бебе преко руке – Док пупак не отпадне и беба не напуни месец дана најбоље је купање преко руке. Рука се ставља испод бебиних груди. На месту где је пупчани патрљак ставити тетра пелену како га не би поквасили. Нежним покретима оперите прво главу, потом труп и руке, а на крају гузу и ноге. Завршно испирање треба да буде из бокала који један од родитеља посипа преко бебиних леђа. Покрети морају бити лагани и без трзаја, како не би уплашили бебу. Веома је важно добро испрати кожу главе због спречавања настанака наслага у пределу темена – темењаче.

Купање бебе у кадици – Пре коришћења кадица се опере, напуни се водом да прекрије бебино тело. Беба лежи на леђима са главицом подигнутом и ослоњеном на мајчину подлактицу, висина главе треба да буде око 5 цм изнад воде. Бебу прво спуштате ногама у воду, па тек онда ослањате на мамину руку или на „купко“. Нежним покретима перете, лице, главу, руке, па се спуштате на доле, гениталије су задње. Након тога иде испирање водом коју сте припремили у бокалу и то ради други родитељ, поливањем од главе, тела и на крају ноге.

По завршеном купању, бебу умотати у памучни фротир који добро упија воду, нежним тапкањем, не трљањем , кожу добро осушити, а кожу главе добро протрљати ,кржним покретима, док се коса потпуно не осуши.

Неки родитељи више воле да обаве купање ујутро, тада је беба обично живља, а родитељи одморнији. Други више воле да купају бебу у вечерњим сатима као део умирујућег ритуала пред спавање, и тада је пожељно бебу купати око сат-два пре ноћног спавања. У оба случаја обратите пажњу да бебу не купате гладну ни непосредно након оброка (пожељно је око сат и по до два сата након оброка). Како год да се определите, време које одаберете није пожељно накнадно мењати, јер бебе воле рутину. Уједначена сатница помоћи ће беби да брзо успостави ритам узимања оброка као и ритам будности и спавања.

За купање је потребно бирати купке и сапуне е који су Рh неутрални (око 5.5), тј. чија киселост личи на природну киселост коже.Уколико је киселост коже испод 4,5 или преко 6 губи се заштитна кожа,долази до већег губитка воде из коже,она се исушује,склона је различитим иритацијама. Креме треба да буду на воденој бази (лат. емолиенс – који омекшава) без алергена , које омекшавају и чувају влагу у кожи. За купање се уместо купки и сапуна препоручују специјални производи – синдети тврди сапун који не иритирају бебину кожу и не одстрањују заштитни хидролипидни слој.

Нега коже

Бебе се не купају свакодневно већ на 2- 3 дана осталим данима се могу пребрисавати малазницама са топлом водом или мицеларном водом. Мицеларна вода – нежно чисти осетљиву кожу бебе и деце, лице, очи, руке, прегибе коже и пеленске регије. Без парабена, фталата и феноксиетанола, сапуна и боја . Наноси се на кожу уз помоћ тупфера, није потребно

испирање. Сви састојци мицеларне воде су преко 98 % природног порекла. Бебе се након купања на кожу могу ставити креме на бази пантенола посебно да прегибне делове. Приликом појављивања црвенила у прегибним деловима, препоручује се само брисање топлом водом, или кратко купање и после сушења, мазање коже кремама на бази цинк оксида. Цинк оксид упија влагу, суши и смањује црвенило коже. Ова препорука се спроводи све док се црвенило са коже не повуче. Пеленска регија код новорођенчета и малих беба посебно је осетљиво и захтевно подручје. Пеленски осип захвата део у пределу које прекрива пелена. Промене могу бити од лаганог црвенила, преко светло црвеног осипа на гузи, полним органима и доњем делу стомачића, до задебљале коже препуне гнојних мехурића. Сматра се да до пеленског осипа доводи непотпуна хигијена током пресвлачења,предуго ношење натопљених пелена, употреба влажних марамница, антибиотска терапија, алергија на неке врсте хране (код одојчета), док код памучних пелена, реакција на недовољно испран детергент и омекшивач и такође предуго ношење влажних пелена. Нека стања погодују настанку пеленског осипа као на пример: ницање зубића, увођење немлечне хране. Пеленски осип се може спечити честом променом пелена, најбоље је након сваког пресвлачења опрати предео испод пелена чистом водом, добро посушити, прскати или нанети неко дезинфекционо средство,сачетати да се осуши и у танком слоју утрљати заштитну крему.

Нега пупчаника и пупчане ране

За негу пупчаног патрљка потребно је припремити стерилну газу, антисептички раствор и перфорирани хипоалергијски фластер. Опрати руке, дезинфиковати их након тога лагано скинути претходно стављену газу наравно никако не одпертлавати траку или скидати штипаљку на пипчаном патрљку. Када смо успешно скинули газу напрскати антисептични раствор око пупчаног патрљка, онда стерилном газом (5×5 цм) очистити пупак, затим другом газом поновити поступак док рана не буде потпуно сува. На крају поново нанети антисептик, ставити стерилну газу и заштитити одговарајућим хипоалергијским фластером. Пупак обично отпада од 5 – 7 дана по рођењу. Док се не сасуши и отпадне, неопходно је једном дневно спроводити негу пупчаног патрљка. Када пупчани патрљак отпадне, остаје рана која се негује и превија као и претходних дана више пута у току дана. У сличају да пупчана рана споро зараста, приметите околно црвенило потребно је јавити се педијатру.За дезинфекцију пупчане ране најчешће се користе повидон јод или октанисепт. Важно је знати да не треба ова средства користити заједно.

Нега чула

Нега ока- очи код бебе су најосетљивије, сузна течност се не састоји само од воде, већ и од соли и од уљасте слузи. Нормално је да се понекад у бебиним очима нађе мало беличастом секрета. Зато је потребно да се тоалета ока ради свакодневно после купања или пребрисавања.Опрати руке, бебу поставити да лежи на леђима. Стерилну газу (5×5 цм) натопити физиолошким раствором. Око пребрисати од спољашњег угла према унутрашњем, једним потезом и газу бацити. Не додиривати својим прстима страну газе којом се брише око. Исти поступак поновити више пута и сваки пут мењати стерилну газу натопљену физиолошким раствором, док се око добро не очисти. Све поновити и на другом оку.Уколико дође до појаве

црвенила, отока очију, секрета који после 2 до 3 дана не пролази или је пак секрет променио боју, веома је важно обратити се педијатру.

Нега ушију-код новорођених беба у спољашњем ушном канулу увек постоји мања количина страног садржаја који не треба одстрањивати. Ушна маст је жућкасте боје, њу не треба чистити, она има своје функције, садржи и незаменљиве материје које делују против бактерија. Тоалета уха се спроводи увек после купања нежним брисањем, тј. врхом памучног пешкира у пределу ушне шкољке, колико може да се дохвати. Избегавати штапиће за ухо, јер њима можемо повредити бебу или унети инфекцију. Погледати обавезно наборе иза ушне шкољке, понекад се може јавити црвенило или осип. Пребрисати тупфером са топлем водом.

Нега усне дупље- промена која се јавља на слузокожи уста и језика код беба у виду беличастих наслага назива се соор или млечац. Бебе могу због тога да слабије једу, па чак и одбијају храну. Инфекција може да настане: приликом изласка бебе кроз порођајни канал, за време храњења и појења недовољно чистим прибором, приликом пада имунитета услед неке болести, код беба које су на антибиотику. У кућним условима нега се спроводи раствором соде бикарбоне (заравњена кашичица соде бикарбоне на 100 мл прокуване и охлађене воде). Оперу се руке, прст се обавије стерилном газом, навлажи раствором соде бикарбоне, а потом се пажњиво скидају насlage. Једним кружним покретом прста по целој усној дупљи бебе. Најбоље је започети са негом пре храњења или подоја никако после оброка јер може доћи до повраћања. Код одојчади такође, посебно када ничу зубићи, пребрисавање има и функцију масажа десни која прија беби. Негу обавњате више пута у току дана, у колико не успевати да санирате насlage након два до три дана обавезно се обратите педијатру.

Нега коже главе- темењача је форма дерматитиса који се јављају код неких беба у првим месецима живота. То прекомерног рада лојних жлезда, које почињу да производе сувише масти. Симптоми су чврсте жућкасте насlage, најчешће на бебиној глави, у виду љуспица. Понекад темењача настаје услед преосетљивост коже главе на препарате за хигијену који се користе, а не исперу се добро, посебно када беба има густу косу или родитељи превише нежно перу бебину косицу, плашећи се бебине фонтане. Два до три сата пре купања потребно је утрљати беби уље на део главе где се налазе насlage. Кад насlage омекшају покушајте да их одстраните четком или чешљићем пажљиво. После купања, прања и довољног испирања косе потребно је беби добро истрљати главицу пешкиром. Након тога, када је коса сува, беби чешљем очешљати косу. Чешља се супротно од раста длаке, дуго и стрпљиво, скидајући део по део наслага. Поступак поновити при следећем купању док се темењача потпуно не повуче.

Нега носа-носић бебе треба цешће чистити, јер су носни канали врло уски и често се ствара утисак да беба отежано дише. Запамтите да новорођенче дише на нос, па запушен нос на првом месту може да знаци отежано сисања, одбијање оброка, лош сан. Потребни су стрпљење и пажња, јер су бебе врло нерасположене када им се дира нос. За испирање носа користи се физиолошки раствор. Беба лежи на боку, у горњу ноздрву се укапа неколико капи физиолошког раствора, беба се благо подигне преко руке главицом на доле и благо лупка по леђима како би избацила садржај зачепљеног носа. Цео процес се може поновити више пут док небудете сигурни да беба може лепо да дише. Вишак секрета одстранити парчетом вате умоченим у млаку воду или камилицу, а остатак секрета извуци стапицем са ватом на врху увученим у врх носнице. Код одојчета и малог детета могу се користити аспитари где се претходно стави физиолошки раствор да би се секрет боље одстранио. Благо подигнуто узглавље (јастучиц испод дусака) може да олакшати дисање и сливање секрета.

Нега ноктију- Бебини ноктићи су меки попут папира, што значи да се веома лако секу. . Углавном не секу се док беба не напуни месец дана. Након месец дана када су нокти мало очврснули можете почети са њиховим скраћивањем. Користе се маказице са заобљеним врхом, пре и након употребе маказице очистити са мало вате намочене у алкохол. Оно што је тешко

извести то је да беба буде мирна све време док јој сецкате нокте. Зато будите стрпљиви и пронађите бебици неку занимацију док јој сецкате нокте. Нокте је најбоље сећи након купања, јер ће тада омекшати па ће те их лакше скратити. Нокте увек сечете у правој линији, без углова, бебин длан и прст придржавате једном руком, а нокат сеците другом руком. Ако је беба немирна ноктиће исећи док спава. Нокти на ногама доста спорије расту, па их није потребно редовно сећи. Као последица полукружног резања и прављења углова приликом резања, може доћи до урастања рубца нокта у мекано месо, или пак до повређивања и лаганог крварења. Тада је најбоље узети стерилну газу натопљену неким антисептиком, лагано притиснути повређено место и сачекати да крварење престане. Ако приметите да се, на месту где је била заноктица, црвени или отиче попрскајте антисептик. Али ако не престаје па још боли бебу на додир и гноји обавезно се јавите лекару.

Нега гениталија код девојчица- гениталије никада не треба прати сапуном или купком, може доћи до иритације и исушивања слезнице.. При брисању гениталне регије водити рачуна да се брише тупфером од вате обилно натопљено топлем водом, од спреда ка анусу, све се обавља у једаном потезу са једним тупфером. Никада обрнуто или трљати горе доле јер тиме би се бактерије са аналног отвора пренеле у вагину. На исти начин обрисати и наборе вулве у којима може заостати сирасти маз. Те беле наслаге се некада тешко скидају и могу бити добра подлога за развој мокраћне инфекције, али се никад не требају грубо скидати. Потребно је раширити велике усне и обрисати тупфером са топлем водом, колико се може. Тако радити редовно после купања, док се потпуно не очисти.

Нега гениталија код дечака- кожа која покрива главич пениса повлачи се нежно уназад, колико може да би се избрисале беле наслаге. За брисање се користи тупфер вате натопљен топлем водом. Беле наслаге су нормална појава, нема разлога за бригу. То су производи лојних жлезда. Дечаци до три године имају физиолошку фимозу, односно сужење и кожица се не може превући до краја. Кожица се повлачи уназад само до границе покретљивости, онолико колико може, а да не боли. Затим се испере топлем водом и кожица врати назад. Код пресвлачења, ако је беба имала столицу, најбоље је добро опрати топлем водом и беби сапуном за прљане делове.

Облачење бебе

Облачење бебе треба да буде у складу са временским условима. Бебе не воле да буду претопљене, не воле пуно слојева одеће. Због тога буду нервозне. Како се сами родитељи облаче тако треба и своје бебе да облаче. Температура собе у којој бораве бебе треба да је од 18 – 22 степена, а за време купања 24 – 26 степени. Нормална температура бебиног тела износи 36,8 – 37,3 степена, када се претопли температура прелази и преко 37,5 степени. Шаке и стопала новорођенчета су увек хладнији. Гардероба треба да буде памучна и лака за облачење. Док се не стекну вештине око облачења бебе препорука је да бенкице и бодићи буду на копчање или везивање. Чарапице не смеју да стежу и праве усеке на кожи. Дугмићи, машинице и разни украси који се вама чине слатки, могу да жуљају бебу, а често се дешава да их беба у игри прогута. Рукавице и капу користити у зависности од временских услова, а посебно када ветар дува. Обућа мора бити удобна, лака за обување и за одговарајуће годишње доба. Лети је пожељно носити затворене сандалице јер код отворених постоји могућност уласка песка, каменчића, ујед инсекта итд.

Положај при храњењу,ношењу и спавању

Положај при храњењу на флашицу- родитељ треба да храни бебу у наручју без обзира на узраст. На тај начин задовољавају њихове потребе за сигурношћу,припадањем, близином и љубављу. Беба се храни да макар мала површина коже буде у контакту са родитељима. Мама треба да удобно седи посматра своју бебу док је храни тако да бебе свакако гледа у мајчино лице.

Када се креће са увођењем немлечне исхране потребно је купити столицу са храњење ако постоји могућност са више положаја. Када беба почиње да једе чврсту храну положај на хранилици треба да буде што нижи односно да беба буде у полуседећем положају. Како бебе буде расла положају се повећавају до стадијума седећег положаја.

Најприроднији и уједно најбољи начин је држање бебе са обе руке ослоњене на крило, а при том јој треба придржавати главу, јер она још увек не може држати главицу без ослоња. Окренута према Вама, она гледа ваше лице и успоставља контакт погледом очи у очи. Мајка инстинктивно бебу ставља на леву руку, вероватно да би чула откуцаје њеног срца, познати, умирујући звук још из стомака. Смешите јој се и причајте топлим гласом лепе речи, шаљите јој поруке колико је волите и ваша беба ће се осећати сигурно. Положај на рамену се препоручује кад беба треба да избаци вишак ваздуха, тј. да подригне непосредно после оброка. Једном руком придржавате потиљак и главицу, а другом гузу. Окрените бебу грудима према себи. Подигните је толико да може да спусти главу на ваше раме, било да гледа у вас или од вас.

Већина педијатара саветује да новорођенче спава на боку. Главни разлог због кога се овај положај сматра најбољим јесте то што, уколико беба бљуцне током ноћи, нема опасности да ће се загрцнути. Након што бебу наместите на бок, иза леђа ставите покривач, како се не би преврнула. За овакав положај бебе је битно да је окрећете више пута у току дана, односно да мењате страну на којој беба спава.

Хигијена бебине гардаробе и бебиног прибора

Бебин веш перете одвојено од осталог рубља,на виском температурама, 60- 90 степени, са малом количином прашка и на програму за дупло испирање. Омекшивач не треба користити јер остаје на тканини и тако долази у додир са бебином кожом.

Стерилизација целокупног бебиног прибора за храњење флашице, цуцле, варалице, глодалице, тањирџи, кашичице. После сваког оброка потребно је опрати руке и детергентом и топлим водом опрати сав бебин прибор уз коришћење четкице за прање. Потребно је темељно опрати прибор и флашице и након тога добро испрати текућом водом и оставити да се осуши.

Стерилизација се обавља у стерилизатору топлим воденом паром, где су флашице окренуте на доле. Овај вид стерилизације се може обављати више пута у току дана када је беба мала, а касније једном дневно. Машина за прање посуђа није препоручљива за стерилизацију бебиног прибора.

Нега одојчета

Вакцинација

Вакцинација се започиње још у породицишту и наставља у периоду одојчета и малог детета. Период заштите који вакцина омогућава уједно и животни период када је могућност да до инфекције дође највећа. Управо зато што имуни систем деце није зрео нити способан да се са инфекцијама сам избори, вакцине се примају у тако раном узрасту. Зато је важно испоштовати Календар имунизације и омогућити период заштите деци када им је она најпотребнија.

Нежељене реакције су могуће, али су код огромне већине деце ти ефекти благи и пролазни, углавном локалне (на месту убода) – оток, црвенило и бол. Оно што углавном брине је што то доводи до нервозе и „кењкавости” беба. Од системских реакција, најчешћи је пораст температуре, који је ретко драстичан, а траје највише пар дана. Уколико дете добије температуру изнад 38,5 или га боли место где је добило вакцину, може се дати парацетамол или ибупрофен, али уз консултацију са педијатром. Када је реч конкретно о ММР вакцини, повишена температура може се јавити чак и после 6 до 10 дана, и тада се сматра уобичајеном реакцијом.

Реакција на месту давања БЦГ вакцине се манифестује као мали црвени плик на месту давања вакцине, који је понекад испуњен течностима беле или жућкасто беле боје или има сукрвице. Спонтано плик пукне и течност исцури, а након тога се на том месту формира малени ожиљак. Реакција на вакцину се обично дешава након пар недеља (3 до 8 недеља).

Шетња

Прва бебина шетња је могућа врло брзо по рођењу – беба може да се износи већ од 15. дана живота, боравак бебе напољу побољшава њено опште стање, расположење, сан, апетит, повећава отпорност према инфекцијама. Дужина боравка зависи и од годишњег доба и климатских услова. Први дан је боравак 5 до 10 мин на тераси, а потом се наредних дана дужина боравка повећава за 10 минута. Препоручује се да се у време летњих месеци беба износи у раним јутарњим сатима или касним поподневним (пре 11 и после 17). Бебама до 6 месеци не наноси се на кожу крема са заштитним фактором. Зими треба бити опрезнији, бебу не изводити док не напуни месец дана, онда је износити кратко и то око поднева. Беба се не изводи напоље уколико је температура веома ниска (испод –10 степени), када дува јак ветар, када пада киша, када је магла или нека мећава.

Увођење чврсте хране

Препорука је да се са испробавањем друге хране почиње између 17. и 26 недеље живота, а када ће који родитељ започети са давањем друге хране беби поред млека зависи од индивидуалних развојних показатеља и договара се са педијатром. Око 6-ог месеца може се очекивати да је

дете спремно за започињање конзумирања друге хране осим мајчиног или млечне формуле. Знаци који нам то показују су: држи главу усправно, повећана је секреција из уста, жели да учествује у оброцима, има понеки зубић, седи самостално. Када се почне са увођењем друге, немлечне хране, она се по својој конзистенцији прилагођава узрасту детета. У почетку је то блединарана/пасирана храна, а што је дете веће, постепено се уводи виљушком изгњечена, па ситно сецкана храна. Избор хране треба да буду здраве намирнице, без додатног додавања шећера или соли. Прва чврста храна требало би да је мекана и млечна. Обично се уведе прво житарице (пиринчане, кукурузне), које су припремљене са млеком или са водом (ако у њима већ има млека), затим поврће (кромпир, шаргарепа, тиквица), воће (јабука, кајсија, бресква). Поврће и воће је кувано или припремљено на пари и пасирано (бледирано). Увек се креће постепено са малим количинама 2-3 кашичице и сваки наредни дан се количина повећава. Дете или седи у крилу или у столици за храњење. Када процените да је згодна ситуација дајте детету кашичицу, са којом ће брљати по тањиру и свуде где може дохватити али и то је начин да што пре почне користити прибор за јело. Различите врсте воћног сока се уводе постепено. Свака нова врста сока се прво даје у малим количинама 2 - 3 кашичице па се количина постепено повећава, сваки наредни дан по 2 - 3 кашичице више. То је веома важно због процене да ли дете алергично на неку намирницу као и привикавање органа за варење на нове намирнице. Сок није неопходан у исхрани детета па га не треба форсирати! Увек је боље да дете поједе целу воћку него да пије само сок. Вода се обавезно даје деци када пију искључиво млечну формулу, када су почела са конзумирањем друге хране поред млека, када су високе спољне температуре или су из неког разлога дехидрирала. Беби може да се да прокувана и незаслађена водоводска вода, нискоминерална и негазирана флаширана вода, као и специјална вода за бебе. Препорука је да се флаширана вода даје из стаклене амбалаже и мањих флашица. Уколико је у пластичној амбалажи, посебно ако је у већим паковањима, прокувајте је пре сваке употребе, а у међувремену држите у фрижидеру. Бунарска вода се не препоручује за децу. До годину дана бебе не би требала да пију пуномасно млеко. Међутим после првог рођендана сматра се да је неопходно да га пију због масноћа које су потребне за развој мозга и централног нервног система. У пракси се најчешће прво креће са житарицама, па са поврћем, након тога са воћем. Разлог за увођење поврћа пре воћа је тај што неке бебе радије прихватају слатке укусе, па ако се крене са воћем одбијају поврће. Ретко која беба прихвати одмах нову немлачну храну. Пре свега то је нови укус, различит од оног на који је навикла. У првој години живота беба сме да једе јагоде, малине, купине, као и друго јагодичасто и бобичасто воће. Оно се уводи у исхрану бебе по истим принципима као и друге намирнице, постепено и помало. Количина се повећава кад се уверимо да беба нема алергију на те намирнице. Обично се прво понуди кувано воће у виду компота, а након тога свеже.

Здраве животне навике

Бирање здравог начина исхране

Изаберите разнобојно поврће, крто месо, свеже воће, интегралне житарице и клоните се скроба, прерађеног меса и процесуиране хране, колико год је то могуће. Идите и корак даље и помозите својој деци да сама узгајају сопствене зачине, поврће и воће у башти, уколико је имате, као и да буду укључена у планирање obroка и избор здраве хране у продавници.

Вода је неопходна за здравље

Када бебе прерасту мајчино млеко и формуле, оне могу почети да пију воду.

Важно је да вода буде чиста и безбедна (ако нисте сигурни у градску воду, користите флаширану), као и да ваша деца увек имају флашицу воде при руци како би навикла да своју жеђ редовно утољују водом, а не млеком или соковима.

Прање руку

Уграђивање навике свом детету да редовно пере руке након одласка у тоалет, повратка споља, пре јела и после мажења животиња је сјајан начин да дете од малих ногу постане свесно и одговорно према себи и свом здрављу.

Редовно прање и чишћење зуба

Свакодневно прање и чишћење зуба је једна од најважнијих навика коју треба усадити детету од најранијег доба. Здавље усне дупље је директно повезано са нашим општим здрављем. Али, још је важније стећи и одржавати навику прања и чишћења зуба двапут дневно, као и избегавање и ограничавање уноса заслађене хране и хране која се лако заглави или залепи у тешко доступним деловима вилице.

Електричне четкице за зубе деци чини прање зуба занимљивим, али и помажу да мала деца (а можда чак и понеки одрасли) боље и детаљније оперу себи зубе.

Дајте важност спавању

Спавање је изузетно важно за раст и развој детета. На умни и телесни развој детета се изузетно негативно одражава немогућност да се тело на прави начин регенерише и изграђује само себе током тих важних сати одмора и сна. Новорђенче треба да има сна у току дана до 18 сати, дневно да спава 3 до 5 пута 1 до 3 сата. Одојче треба да има сна око 14 сати, дневно спава 2 до 3 пута по 2 сата ноћу око 12 сати сан. Мало дете око 13 сати сна од тога 1 спава у току дана око 2,5 сата ноћу око 11 сати.

Хигијенске навике

Хигијенске навике обухватају редовно купање, прање косе, свакодневну негу зуба, чисту одећу, једном речју уредност. У томе наравно не треба претеривати, јер је деци (нарочито оној малој) неопходно да се играју напољу, што са собом свакако носи флекање и прљање.

Дентиција

Појава првог зубића за родитеље је често повод за славље, али може бити извор стреса и непроспаваних ноћи. Раст зубића обично почиње између 3. – 6. месеца. Понекад се беба роди са зубићем, а некад добије свој први зуб тек кад прохода. Тегобе које се могу јавити при ницању зубића су: појачано лучење пљувачке, стављање руку у уста, одбијање чврсте хране, отечене, црвене и болне десни, раздражљивост, узнемиреност, буђење у току ноћи, појава течније столице (никако пролива) и понекад благо повишена температура (не преко 38 степени).

Како да помогнете детету:

Расхлађивањем десни – користите глодалице које се могу охладити у фрижидеру, немојте их држати у замрзивачу јер се беба може повредити залеђеном глодалицом. Глодалице су обично гумене или направљене од специјалне пластике, различитог облика и дезена прилагођене беби.

Масажом десни – оперите добро руке и кажипрстом масирајте бебине десни. На тржишту можете пронаћи више врста гелова или течности са којима се врши премазивање и масажа десни. Гелови садрже лековите биљаче, хијалуронску киселину или анестетик са локалним дејством. Користите их према упутству произвођача, адекватно узрасту детета.

Скретањем пажње – пробајте да усмерите детету пажњу на неки нови предмет, играчку, појаву. Изведите дете у шетњу, глумите, певајте, носите дете, тешите дете.

Појачано лучење пљувачке може да изазове иритацију или осип око усана, што може бити погодно место за инфекцију. Да бисте то избегли редовно умивајте бебу, посушите предео око усана, намажите неутралну, заштитну крему. Испод главе током спавања ставите памучну пелену и често је мењајте, како би бебино лице и образи увек били суви.

Путовање

Пре поласка треба знати где се путује, који превоз се користи, какви су услови смештаја и добро испланирати шта понети на одмор од неопходних ствари, нарочито за бебу. Обавезно је да место у које путујете има обезбеђену здравствену заштиту! Најмање 5 дана пре поласка почети са уносом пробиотика и продужити са давањем за време боравка, како би адаптација на вирусе и бактерије из околине била што безболнија, како не би дошло до стомачних инфекција. Ако се ради о даљим дестинацијама, дужем путовању, препорука је да се користи авионски превоз. Понесите цуцлу за бебу, ако беба не сиса, да би при слетању и полетању смањили притисак у ушима. У ручном пртљагу понесите резервну пресвалку за бебу, обавезно неко ћебенце и играчку. Путовање аутомобилом има своје предности јер сами одређујете време паузе. Ауто седиште је обавезно и потребно је да старија особа седи поред детета на задњем седишту.

Летовање

Са дететом старости до 2 месеца не би требало планирати одмор.

Ако се родитељи одлуче за одлазак на море или планину, требало би се добро распитати да ли је средина безбедна за дете, има ли место лекара и апотеку, каква је снабдевеност маркета и какав је смештај. Соба би требала да има све оно што је потребно за боравак бебе. Децу до годину дана не би требало излагати директним сунчевим зрацима. Гардероба коју дете носи од природних материјала, шеширић на глави обавезан, наочаре за сунце са заштитом од УВ зрачења. Не боравити напољу у периоду између 10ч – 17ч. Сунцобран и крошња дрвета нису довољна заштита у том временском периоду. Брчкање у води само у чврстом мамином или татином загрљају, неколико минута, под условом да је вода топла. Могуће расхлађивање може бити и у базенчићу, под непрестаним надзором. По изласку из воде (било да је море или базен) потребно је кожу бебе испрати са обичном водом. Децу до 6 месеци не мазати заштитним кремама, а после 6 месеци са СПФ 50+, свака два сата. Током врелих летњих дана свакако је боравак у раслађеној просторији пријатнији. Препоручује се укључивање уређаја у просторији поред собе у којој борави дете, ако је то могуће. Ако није могуће клима уређај не би смео да дува хладан ваздух директно у дете. Разлика између спољашње температуре и температуре у просторији не би требало да буде већа од 5 до 10 степени. Уређај треба редовно да се чисти и сервисира.

Зимовање

Зимска гардероба иначе заузима више места у пртљагу, имајте у виду да је деци потребно понети по више комада истог одевног предмета, предлагемо да направите списак. Јакна, капа, скафандер, непромочива обућа, рукавице, хулахопке ... све ово вам је потребно дупло. Рачунајте да ће се дете много брже поквасити али и ознојити тако да је неопходно да имате увек суву замену. Исхрану за време боравка прилагодите дететовом узрасту и временским условима. Детету обезбедити топле чорбасте, куване оброке (нарочито после боравка на снегу). Често нудите воду и топле напитке чајеве, компоте... (у приватном смештају је неопходно обезбедити залихе намрница које су детету потребне, као и пелене, средства за хигијену). Боравак напољу је препоручљив за децу у најтоплијем делу дана (избегавајте излазак ако је магла, олуја или јак ветар). Чувајте децу од поледице, посебан опрез на скијашким стазама као и стазама за санкање на којима је велики број деце. Избегавајте дуге, исцпљујуће шетње уколико је температура у минусу. Шетајте познатим, утабаним, прилагођеним стазама.

Нега болесног детета

Грчеви

Грчеви су пролазна појава и ни на који начин не угрожавају бебу.

Постоје технике којима можете ублажити интензитет грчева, смањити учесталост и дужину трајања. Опште препоруке-узмите бебу у наручје и покушајте да утешите бебу: нежно јој причајте, тешите је, мазите, љуљушкајте, ставите поред дојке ; положај у коме сте обезбедили контакт „кожа на кожу“ највише прија беби;

може помоћи ако мајка која доји из исхране искључи кравље млеко и млечне производе, намирнице богате простим шећерима (слаткише), зачињену храну, газиране напитке, као и намирнице које надимају; после подоја или храњења на флашицу, подигните бебу да подригне, јер мехурићи ваздуха који су се задржали у желуцу могу ометати процес варења; ако беба брзо и халапљиво једе успорите храњење , одвојите бебу од дојке, подигните је да подригне, па наставите са храњењем; благотворно делује масажа бебе - целог тела или барем масажа стомачића у правцу кретања казаљке на сату; понекада помогне загрејана пелена или топао беби термофор нежно постављен на бебин стомачић. Опрез – немојте стављати термофор директно на бебу кожу!

Шта још може да буде од помоћи? Неке бебе се умире када је око њих мир и тишина, а неким је потребна лагана умирујућа музика; неке реагују на промену околине, неке воле возњу, неким је довољна шетња у наручју; неке бебе смирује сисање, али је важно да не претерате са храњењем ; познато је да купање и топла купка опуштају, а после купања добро је масирати табане ; неке бебе реагују на такозвани „бели шум“, звук фена, усисивача, шум таласа, звук падања кише; понекада смирење настане када се беба не дира и пусти да се сама утеши. По препоруци педијатра се могу користити пробиотици, ензими или препарати симетикона.

Осип по телу, пеленски осип

Бебина кожа је веома осетљива, посебно у подручју пеленске регије. Промене на кожи у облику црвенила које захвата мање или веће површине, у виду оспе, ситних или мало крупнијих тачкица, у пределу који покривају пелене, назива се пеленски осип. Заправо, то је упала нежне и незреле бебине коже. Запажено је да појави пеленског осипа погодује недовољно мењање пелена и непотпуна хигијена током пресвлачења, коришћење влажних марамица, антибиотска терапија, дијареја/пролив, алергија на неке врсте хране или на гел из једнократних пелена, реакција на детерџент и омекшивач код употребе памучних или тетра пелена, као реакција на препарате за негу коже. Исто тако и претерно прање , купање, посебно ако се сваки пут користе сапуни, може да доведе до иритације, нарушавања заштитног филма коже , па самим тим и до црвенила, пуцања коже, а затим лакшег настанка инфекције коже у том делу. Родитељи, или они који се баве бебама, треба редовно да мењају пелене (на свака два - три сата), а кад беба има столицу је треба што пре пресвући. Наравно ако беба тада спава, бебу не треба будити да би је пресвачили. Најбоље је приликом сваког пресвлачења опрати предео испод пелена чистом топлом водом, добро испрати гениталије, гузу и прегрбе, просушити тапкањем и пустити да се кожа добро осуши, ставити танак слој заштитне креме , па тек онда пелену. Влажне мараме користити само у изузетним приликама. За чишћење пеленске регије треба користити обичну топлу воду или мицеларну воду за бебе. Болна подручја није добро брисати. Нежно отклоните остатке

столице. Бебу што чешће оставити голишаву бар по пет, десет минута при пресвлачењу. Узгред, бебама прија када су "ослобођене" од пелена, а сушење коже је саставни део лечења пеленског осипа. Понекада помогне само промена креме или пелена другог произвођача. Препорука је да се користе креме са цинк оксидом јер оне смирују упалу и суше влажну кожу или креме специјално намењене за ту намену. Избегавајте влажне марамице.

Инфекција ока

Када се појави појачана секреција у оку, потребно је стерилном газом и физиолошким раствором очистити око. Газа се натопи физиолошким раствором и око се чисти једном газом, једним покретом руке, од спољашњег угла ока ка унутра. Не враћа се истом газом назад преко ока. Поступак се понови још једном, па се у чисто око укапа стерилан раствор борне киселине посебно за ту намену. Поступак се примењује три пута дневно, али ако се секреција појачава, појављује црвенило или оток очног капка, односно стање погоршава, потребно је јавити се лекару.

Начин неге око и лечење

Тупферима стерилне газе натопљене физиолошким раствором уклонити све нечистоће ока од спољашњег дела ока ка унутрашњем, односно ка корену носа, користећи за сваки покрет нови тупфер газе. Бебу/дете ставити у лежећи положај или седећи са благо забаченом главом уназад ако то узраст детета дозвољава; приликом укапавања капи у око, треба повући доњи капак надоле, да се боље види а и ослободи коњуктивална кеса/унутрашњи простор доњег капка;/ ако је дете старије замолити га да гледа нагоре и према споља; укапати прописан број капи у око; старијем детету рећи да трепне, мала беба ће рефлексно трепнути и на тај начин ће се лек распоредити по оку; извршити благ притисак на тзв. сузно језерце ока, односно унутрашњи угао ока, ка корену носа од неколико секунди да се капи не би излиле из ока; код nanoшења масти, нежно истиснути танак слој масти дуж коњуктивалне кесе/унутрашњост доњег капка/, од унутрашњег према спољашњем углу ока.

Запушен нос

Код беба и деце која су прехлађена, а нос је пун секрета обавезно је редовно чишћење носа. Бебе дишу преко носа, па је неопходно запушен носић учинити проходним, јер секрет у носу отежава сисање. Нос треба испирати са препаратима физиолошког раствора или пречишћене морске воде, наквашен секрет извлачити, онолико пута колико је потребно да се обезбеди проток ваздуха односно дисање, осим код беба узраста до 3 месеца када је потребно бити посебно опрезан. Изузетно су zgodни, једноставни и лаки за употребу препарати у виду спреја као и беби аспиратори (пумпице), који помажу родитељима да очистите секрет брзо и ефикасно, те учине да њихово чедо прехладу лакше прегура. Нос се чисти обавезно пре јела, ако чистите нос после јела, можете изазвати надражај за повраћањем.

Вакцинација

Ако дете има повишену телесну температуру након добијене вакцине, преко 38,5 степени, могу се давати лекови (антипиретици) на бази парацетамола (Парацет, Ефералган, Фебрицет...) или

ибупрофена (Бруфен,Нурофен...) , водећи рачуна да се доза прилагоди узрасту и телесној тежини детета.Најбоље је да дозу лека одреди педијатар. Давање лекова у напред је непотребно. Кад дете добије прву вакцину, нежељени ефекти су заиста ретки и благи.Уколико се користе савремене вакцине, прва вакцина скоро никада не узрокује повишену температуру. Уколико се на месту давања (апликације) вакцине јави оток, црвенило, бол, слободно се може ставити хладна облога.Мекана памучна тканина се натопи са хладном водом па се ставља на отечено место.Понекада се јави и пораст температуре као системски нежељени ефекат који пролази за дан - два.Уколико температура пређе 38,5*Ц, дати детету лек за снижавање температуре (антипиретик). Са побољшањем процеса производње вакцина ове компликације су права реткост. На месту давања БЦГ вакцине (горња трећина леве надлактице,ближе рамену) се у периоду око 10 недеље живота може појавити мали плик,обично не већи од 0,5 цм,испуњен мутном,беличастом жутом течностју или сукрвицом, околина је благо црвена. Плик (мехурић) испуњен овим садржајем после неколико дана пукне, садржај исцури, остане мала раница која траје неколико дана, а на том месту остаје ожиљак. Никакав посебан третман обично није потребан.Беба се може купати и ништа је не боли.Кад плик пукне и садржај се издренира (исцури) у спољашњу средину,оставити мало откривену ручицу да се раница сасуши, не треба стваљати газу.Она се обично залепи за раницу,па њено скидање направи исти проблем. После давања ММР вакцине се може јавити реакција у периоду од 7. – 14 дана након вакцинације.Реакција може бити у виду повишене телесне температуре,оспе,отока жлезда иза ува.Обично траје неколико дана и нема компликација.

Повраћање - Опстипација – дијареја

Повраћањем бебе веома брзо изгубе већу количину течности и електролита (соли,минерала) и улазе у стање које зовемо дехидратацијом, које може бити опасно за бебу. Потребна је надокнада течности и електролита уношењем мањих количина течности, често и на прописан начин. Препорука је да се 30 минута након последњег повраћања детету не даје ништа. Чека се да се смири грчење желуца и престане нагон за повраћањем.Након тога се сваких 3-5 мин. даје по кашичица – две течности са електролитима и тако 30 мин.Ако нема повраћања количина течности се може повећати. Ако спроведена рехидрација не даје резултат и дете настави да повраћа,може се поновити поступак једном или два пута (у зависности од стања детета). Ако је рехидрација успешна и дете не повраћа након 3 до 4 сата од започете рехидрације се даје прва храна (супа,компот,барено поврће), али ако се стање не побољша дете треба одвести код лекара. Бебе које повраћају сваки оброк у млазу ,у прва три месеца захтевају без одлагања одлазак лекару.

Опстипација-Ако се беба храни маминим млеком изостанак столице се може толерисати од седам до десет дана, зато што се највећи део из мајчиног млека искористи. Ако је пак на млечној формули, тај временски период је обично краћи 2 -3 дана, под условом да беба због изостанка столице нема никакве тегобе. Можете помоћи беби масажом. Масирајте бебин стомак кружно у правцу казаљке на сату.Беба лежи на леђима,ваше руке требају бити топле, узмите пар капи беби уља, протрљајте их између дланова и масирајте стомачић, као "свирање клавира" прстима око пупка, лагано, неколико минута. Масирајте бебина стопала, "јастучиће" испод прстића, кружним покретима. Урадите вежбе.Савијајте леву ногу у куку и колену према стомаку , покушајте да је приближите бебиној десној руци, према лакту и тако наизменично, десна нога – лева рука.Након тога ногице савијене у куковима и коленима лагано усмерите и полако притисните ка стомаку, неколико пута.Радите вежбе као да беба "вози бицикло" ногицама неколико пута. Овим вежбама помажете да се бебина црева покрену. Ако беба пије млечну формулу обратити

пажњу на начин припреме млека , прецизно, по упутству уз појење детета између obroка прокуваном, охлађеном водом (или флашираном нискоминерализованом или специјално намењеном за бебе). Код старије деца која једу и друге намирнице поред млека поред већ предложених мера (масаже, вежби и повећаног уноса течности), потребно је повећати унос одређених намирница :компот од сувих шљива, кајсије, бресве, урме, житарице, мекиње. Искључиво по препоруци лекара се могу користити микроклизме и одређени сирупи који имају лаксативно дејство.

Дијареа /пролив је стање које захтева преглед педијатра и лечење по препоруци педијатра. Обично се саветује примена пробиотика, чешће храњење детета , надокнада течности и давање електролита. Ако беба сиса треба чешће да сиса, ако пије млечну формулу лекар некада саветује промену врсте формуле и даје се формула специјално намењена за таква стања. Ако беба једе поред млека и неку другу храну саветују се : кропир, пиринач, барено поврће са младим месом, доста супе, компот од јабуке , печена јабука, избегавање свежег воћа, воћних сокова који због већег садржаја шећера некад могу додатно да иритирају слузокожу црева и доведу до додатног повећања броја столица. Код мале деца која пију кравље млеко, оно се обично привремено избацује из исхране детета или се саветује примена млека без лактозе. Кисело млечни производи се могу узимати у највећем броју случајева. Постоје стања када је потребно да се из исхране избаце и кравље млеко и кисело млечни производи, као и сви индустријски производи у којима има млека. О томе одлучује педијатар.

Висока температура

Поступак за снижење температуре се примењује када дете има температуру изнад 38,5 степени мерено испод руке у подпазушној јами. Потребно је детету дати сируп за снижење температуре на бази парацетамола или ибупрофена (у зависности од узраста и према телесној тежини детета). Расхладити дете купањем у млакој води до 10 минута. Вода не сме бити хладна. Дете не треба да осећа језу и дрхтавицу. Ставити неку играчку у воду и покушати забавити дете.

Расхладити просторију ако је температура у просторији преко 22 степена.

Детету обући тању памучну гардеробу. Не претопљавати дете.

Појити дете течношћу, ако сиса понудити га чешће да сиса. Пратити стање детета, контролисати висину температуре и уколико се температура враћа, висока је, дете лоше изгледа треба га одвести лекару. Дете обавезно и без одлагања одвести лекару ако се ради о детету млађем од 3 месеца, ако је температура виша од 40 степени, постоји укоченост врата, главобоља и повраћање, постоји осип, отежано дисање, гутање, дете неутешно плаче, осетљиво је на додир, необично поспано, одаје утисак „веома болесног“, одбија да једе и пије, дехидрирано је (значи дехидратације су :упале очи, плакање без суза, сува уста, увучена фонтанела, суве пелене, обложен језик).

Ако постоји **хипотермија** (ниска телесна температура испод нормалне) потребно је пре свега проверити тачност измерене температуре (различити топломери могу услед неправилне технике мерења да покажу различите вредности температуре). Након тога ако је температура ниска , потребно је утоплити дете пазећи да не почне да се зноји (тада температура пада), појити топлим напцима, чешће мерити температуру (на 15 мин - 30 мин), пратити опште стање детета . Уколико је лоше опште стање детета (јако поспано, одбија да уноси течност , малаксало, бледо или са модрим рукама и ногама) , температура нижа од 35 степени потребно је јавити се лекару.

Дете које има напад **фебрилних конвулзија** треба положити на бок како не би дошло до западања језика. Није потребно детету насилно отворати уста, нити је потребно ударати дете. Хладити дете и дати лек за снижење температуре у облику чепића као и Диазепам ако га је лекар преписао. Пласирати га ректално. Кад напад прође одвести дете у болницу.

Повреде и незгоде

Код узраста до годину дана, најчешћи узроци повреда су гушење или загрцнутост, механичко дављење јастуцима, пластичним кесама, мрежицама на кревету. Такође, ризични су и падови са кревета, стола за повијање, из дубка, као и опекотине услед купања у врелој води.

Деца од прве до четврте године најчешће се повређују тако што падају са висине. То не мора да буде пад са терасе; довољно је озбиљно ако дете падне са неке полице или стола који су виши од њега. Други узрок повређивања деце овог узраста је гутање страног тела (кликера или ситних играчака). Такође, опасне су и опекотине које најчешће настају у ситуацијама када мајка кува ручак па непажљиво остави дршку окренуту ка ивици, јер дете лако повуче читав лонац и проспе по себи. Најзад, велики ризик се јавља и због тровања препаратима кућне хемије или козметичким производим.

Најчешће повреде на игралишту настају услед падова са справа и то пре свега љуљашки и клацкалица, а врло су честе и повреде због лоше одржаване опреме када се деца посеку или убоду на неки ексер или искидани део опреме који вири.

Падови су код деце најчешћи начин повређивања. По природи радознало, дете ће се готово свакога дана, понекад и више пута дневно, наћи у ризику од пада - било да је у питању пад са полице у кући, са пењалице на игралишту, са дрвета у дворишту или парку.

Шта урадити када дете падне; смирите га и утешите умирујућим додиром и речима; на месту где је настала модрица ставите му хладан облог или лед (увијен у крпу или марамицу); уколико се дете приликом пада жали на јак бол у нози или руци и не може или тешко хода, а на месту удара постоји изражен оток, треба мислити на постојање уганућа, ишчашења или прелома; уколико се приликом пада дете посекло- код обичних површних раница, рану можете испрати водом и сапуном како бисте уклонили прљавштину; уколико постоји крварење -треба га зауставити; уколико је дете приликом пада ударило главу, али није губило свест и понаша се нормално, пажљиво пратите његово понашање у наредних 48 сати, како бисте уочили необичне знаке који могу указати на постојање теже повреде. **Дете одведите код лекара уколико:** је веома спавано или се тешко буди, се жали на вроглавицу, почне да повраћа, се жали на болове у глави, врату или леђима, не може нормално да хода, користи или савија ноге или руке или осећа велики бол при покретима или на месту ударца, се жали на проблеме са видом, приметите да не може нормално да фокусира очима.

Свака врста физичке активности - трчање, скакање, пењање, вожња бицикла, али и обичан ход по равном може довести до настанка повреде у било ком узрасту. Четири основне врсте повреда мишића, зглобова и костију су **истегнућа, уганућа, ишчашења и преломи.**

Најчешћи знаци и симптоми повреда мишића, костију или зглобова су: бол и nelaгода који се појачавају при покрету; оток на месту повреде; облик зглоба или кости који одступа од нормалног; неприродан положај повређеног дела тела; немогућност коришћења или покретања повређеног дела тела;хладан и неосетљив повређени део тела. Шта можемо да урадимо: покушајте да утешите дете и реците му да се не помера; повређени део тела имобилишите у положају у ком је затечен- можете га подупрети нечим меким (јастуче и сл.) или га придржавати вашом руком; повређени део тела учврстите удлагом само онда када дете морате да померите због непосредне опасности или стања којезахтев хитан транспорт у здравствену установу; на повређени део тела, уколико кожа није оштећена, ставите пластичну кесу или крпу са ледом и држите је најмање 20 минута. (Ове облоге можете стављати наредних 48 сати на сваких сат времена и држати их око 20 минута.);повређени део тела држите у нивоу срца или га благо подигните, али само уколико тај покрет не наноси додатни бол детету.

Крвни судови у носу су јако осетљиви код мале деце и често могу бурно реаговати и на мали ударац. **Крварење из носа** често може настати и због сувог ваздуха, врућине или нагле промене температуре- нпр. када дете из воде изађе на сунце, а може се јавити и у току сна. Често изгледа веома драматично, али у највећем броју случајева лако се зауставља. Како да зауставите крварење из носа? Дете умирите и поставите га да седне, са главом благо нагнутом напред. Вашом руком му стисните или му реците да држи стиснуте обе ноздрве, и држите тако 5-10 минута. Ставите му хладне облоге на чело, на корен носа и око врата. Након 10 минута погледајте

да ли је крварење стало, уколико није, поновите поступак. Уколико се ни након трећег понављања (30 минута) крв не заустави, одведите дете у дежурну амбуланту за ухо, грло и нос, где ће му они пружити стручну помоћ.

Мала деца су чешће изложена **опекотинама** од просуте вреле течности или опекотинама услед додира врелих површина (перна, рингла, пегла и сл.). Старија деца се најчешће повређују у директном контакту са пламеном (ватра, шибице, прскалице и др.), различитим пиротехничким средствима (петарде, ватромет и сл.) или страдајући од струјног удара.

Дете се опекло- шта да радите? Прво уклоните извор топлоте; Мању опекотину охладите млазом или потапањем у хладну воду, најмање 10-20 минута, а за тим, по потреби, потражите медицинску помоћ. Преко опекотине можете ставити хладне облоге, најбоље навлаштену стерилну газу (30-45 мин). Површину опекотине хладите све док не престане осећај бола.

Што пре уклоните сву одећу и накит са опечене површине. Уклањање одеће и накита је важно, јер они додатно могу задржавати топлоту на кожу и ограничити проток крви у опечено подручје, уколико дође до отицања тог дела тела. Са опечене коже никада немојте на силу скидати одећу која се залепила, јер можете проузроковати додатно повређивање. Опечено место нежно прекријте стерилном газом или чистом тканином како бисте спречили настанак инфекције.

У складу са узрастом детета можете му дати лек против болова (парацетамол или ибупрофен, у дози у складу са његовим узрастом) детаљно се придржавајући упутства произвођача. Уколико дете није раније узимало ове лекове обавезно консултујте свог педијатра због могуће алергијске реакције.

Бројни препарати који се свакодневно користе у домаћинству садрже веома **отровне састојке**. Средства за чишћење и машинско прање, козметички препарати, лекови, алкохол, опијати, антифриз, бензин, отрови за глодаре, средства за заштиту биљака, отровне биљке и гљиве – све побројано представља само неке од могућих извора опасних отрова. Додатну опасност представљају отровне паре и гасови који настају услед пожара, при сагоревању чврстих и течних горива, цурењу неисправних гасних инсталација, или издувни гасови аутомобила уколико се мотори укључи у затвореној гаражи.

У случају удисања отрова или отровних гасова: Заштитите себе, јер Вам отровни гасови могу нашкодити. Што пре изведите дете на свеж ваздух. У случају гутања отрова: Удаљите извор отрова од детета. Подстакните дете да испљуне из уста непрогутану количину отрова, или отров из уста уклоните прстима. Не изазивајте повраћање. У случају да је отров нанет по кожи: Уклоните са детета одећу натопљену отровом. Најмање 15 минута испирајте кожу млаком водом. Не наносите креме или масти на повређену кожу. У случају да је отров упао у очи: Испирајте очи млазом млаке воде током 15 минута, од унутрашње ка спољашњој страни очију, држећи очне капке отвореним. Не покривајте очи газима, тканинама и сл. Не стављајте капи или масти у очи без претходног саветовања са лекаром.

Деца **"нешто прогутају"** најчешће у првој години живота. У том узрасту деца почињу да пузе, да откривају свет око себе, стављајући у уста све на шта наиђу. Такође, до гушења може доћи док дете једе, када залогај или нека течност, најчешће ако се дете смеје, уместо у дигестивни тракт упадне у дисајне путеве. Већа страна тела (коштице воћа, делови играчака, бомбоне) обично се зауставе на уласку у дисајне путеве, у гркљану или на почетку душника. Мања страна тела могу продрићи дубље, све до плућа. И мека храна (на пример виршле, кобасице, грожђе, и карамеле), ако није ситно исецкана, може да блокира душник, а самим тим и да доведе до гушења. Дете се гуши - Шта да радите док помоћ не стигне? Најпре храбрите дете да кашље! Спонтани кашаљ представља најбољи начин за уклањање страних тела из горњих дисајних путева. Ако дете није у стању да кашље, ако не дише, сместа избаците страном тело из дисајних путева детета и започните оживљавање. За избацивање страног тела примењују се ударци по леђима, односно притисци на грудни кош.

Заразне болести

Већина невакцинисане деце добија **овчије богиње**, најчешћу дечју заразну болест. Две до три недеље по изложености инфекцији појави се осип који сврби, најпре на труп, а затим и на осталим деловима тела. Осип се састоји од ружичастих тачкица које се брзо претворе у пликове испуњене течностима. После око пет дана настају крастице које нестану најчешће у року од две недеље. Првих дана дете обично има температуру. Осип са пликовима обично се прво појави на труп, а потом се шири на друге делове тела. Дете које има варичелу (овчје богиње) може да се купа, туширањем, млаком водом. Купање је веома важно зато што се на тај начин спречава настанак инфекције. Препоручује се антисептички гел за купање. Након купања кожу треба посушити тапкањем нежним, меканим фотиром, пажећи да се пликови на кожи не покидају. По сушењу промене на кожи треба намазати кречним млеком, талком или спрејем за ту намену по препоруци педијатра.

Заушке - Ова болест изазива натицање и болну осетљивост једне или обеју пљувачних жлезда испод ушију. Често је прате температура, болови у ушима и главобоља. Знак препознавања ове болести је отицање пљувачних жлезда. Жвакање може бити болно и у тим ситуацијама дајте детету благу супицу или другу мекану храну, а избегавајте храну јаког укуса или киселу, као што су сок од поморанце, ананас или парадајз. Болест обично траје недељу дана.

Шарлах је још једна осипна болест, изазвана бактеријом стрептокок, која се обично налази у ждрелу и може изазвати упалу грла. Ово је изузетно заразна болест, а осип наступа три до пет дана након инкубације. Осип је веома специфичан, најпре захватајући труп, врат и екстремитете, док су образи румени, а кожа око уста бледа. Будући да се ради о бактеријској инфекцији, лечење подразумева терапију антибиотикима, које лекар преписује и којима се спречавају евентуалне компликације. С обзиром да је ова болест праћена температуром, дете нема апетит и губи течности и минерале, што би требало да се надокнађује честим и малим оброцима. Температуру ваља држати под контролом лековима на бази парацетамола. Важно је знати да се шарлах може преболети више пута.

Ујед инсекта

Деца су у повећаном ризику од убода инсеката јер управо она највише времена проводе напољу када је лепо време, а њихова немирна природа их нагони да додирују инсекте, тако да често бивају убодена услед своје радозналости и непромишљености. Већина убода инсеката пролазе као блага стања, узрокујући само ограничене промене на кожи, свраб или оток на месту убода, које пролазе без икаквих последица. У неким случајевима, убод пчеле, осе или стршљена може изазвати алергијске реакције опасне по живот, док су комарци потенцијални преносиоци различитих заразних болести. У продаји се налазе бројна средства, тзв. репеленти, која директним наношењем на кожу (спрејеви, лосиони, марамице, и сл.) или испаравањем (таблете, течности и сл.) одбијају различите инсекте, пре свега комарце, са тела или из просторија у којима се борави. Приликом куповине ових производа морате, поред њихове ефикасности, узети у обзир и њихову потенцијалну штетност, нарочито када су у питању бебе и мала деца, чији су кожа и дисајни путеви осетљивији.

Промене и реакције које настају као последица убода инсеката најчешће се могу испољити као: промене на месту убода и као реакција која погађа целокупан организам детета.

Лечење промене на месту убода укључује следеће поступке: Умирите дете, и не дозволите му да чеше место убода. Уклоните жаоку нежним покретима тупим предметом (нпр. тупом страном ножа). Ово је важно учинити што пре јер докле год је у кожи, жаока наставља да испушта отров. Исперите место убода водом и сапуницом. Поставите хладу облогу (на пример, лед обмотан тканином) на место убода како бисте умањили бол и оток. Држите облогу највише 15 минута, и никада не стављајте лед директно на кожу, већ искључиво обмотан тканином. Уколико се убод налази на руци или ноzi, потребно је уздићи руку или ногу како би се смањио оток. Након појаве локалних промена, потребно је да будно пратите опште стање Вашег детета у наредним часовима како бисте на време уочили могућу појаву озбиљне алергијске реакције.

Ујед крпеља превенирати: Потребно је избегавати места за шетњу несређеним и нетретираним травнатим површинама. Дете треба да носи шеширић, гардеробу од прозрачних тканина, али дужих рукава и ногавица, а на незаштићене делове тела треба намазати репеленте одговарајуће за узраст детета. По доласку кући, истрести гардеробу, прегледати и исцешљати косу, прегледати кожу. Ако ипак приметите крпеља, не треба га мазати никаквим уљима, алкохолом или било којим другим средством. Потребно је да се дете одведе у здравствену установу да би крпеља извадило стручно лице, што раније, а најкасније у року од 24 часа од момента убода. Крпеља треба однети на анализу да се провери да ли је био заражен. Уколико је био заражен лекар доноси одлуку о томе да ли треба профилактички (превентивно) давати антибиотике. Место убода и здравствено стање се прати месец дана. Ако се на телу појави црвенило прстенастог карактера, повишена телесна температура, главобоља, болови у мишићима, зглобовима, увећање лимфних жлезда обавезно је да се дете одведе лекару.

Алергије

Алергија код деце је веома честа појава. Свако дете може развити алергију, али је чешћа код деце из породица код којих се у историји болести јављају алергијске реакције. Симптоми који недвосмислено могу указати на присуство алергије су: Кожни осипи, потешкоће са дисањем (астма), кијање, кашљање, цурење носа и/или свраб очију, проблеми са стомаком, попут дијареје, повраћања или грчева. Алергени се могу поделити на-Спољашње: полен дрвећа, полен биљака или убода инсеката; Унутрашњи: длака или крзно кућних љубимаца, гриње, плесни; Надражујуће честице из ваздуха: дим цигарете, парфема, издувни гасови аутомобила; Храна: кикирики, јаја, кравље млеко и млечни производи, орашаста плодови. Алергијски ринитис је најчешћа дечја болест коју изазивају алергије. Симптоми укључују цурење и сваб носа, кијање и зачепљење носа. Дете са алергијама такође може осетити свраб очију, које могу постајати влажне и црвене. Алергије су најчешћи узрок хроничне зачепљености носа код деце. Понекад је дечји нос зачепљен до те мере да је дисање могуће искључиво кроз уста, посебно током спавања. Најчешће алергени код деце су кикирики и кравље млеко; остали често виђени окидачи укључују јаја, рибу, шкољке, орашаста плодови и пшеницу. Сви родитељи деце са алергијом на храну треба да буду свесни могућности анафилаксије – потенцијално опасне по живот, реакције која нарушава дисање, изазива нагли пад крвног притиска и доводи тело у стање шока. Први корак у спречавању појаве алергијске реакције је избегавање контакта са алергеном. У пролеће је важно избегавати боравак напољу у јутарњим сатима када полена има највише у ваздуху. Ако је већ неопходно применити лек онда је први избор антихистаминик који блокира ослобођен хистамин и тиме ублажава симптоме. Лек или сируп се користи у консултацији са педијатром.

Путна апотека

Одлазак на пут са дететом изискује детаљне припреме, а морате се спремити и за непредвиђене ситуације. Тако да је приручна апотека обавезан део пртљага. колико се беба или дете прехлади, добије температуру, заболи је уво и слично, потребно је да се претходно консултујете са лекаром па тек онда да посежете за својом приручном апотеком. Никад не знате када ће нека незгода, дечја температура, ујед инсекта, захтевати вашу реакцију, а лекарска помоћ није увек близу, а није увек ни неопходна. Путна апотека треба да садржи: Топломер, Лек (сируп или чепиће) за снижење температуре на бази парацетамола или ибупрофена, Дезинфекционо средство за ране, огуљотине, огреботине, посекотине (намењено за употребу код деце), Фластер (може са цветићима и другим сличицама), Газе (неколико малих, неколико већих), Завој (ужи и шири), Крема у случају уједа инсекта и алергије (одговарајућа узрасту детета), Крема за опекотине, Крема против оједа, Физиолошки раствор за испирање очију и носа (вишек комада, малог паковања од 5 мл), Пробиотик, Електролите, Сируп против алергије по препоруци педијатра, Лекове за децу која пате од хроничних болести по препоруци педијатра.

Давање лекова

Забринути су да ли исправно дају лек, да ли ће га дете/беба попити у целости и шта урадити уколико дете лек проспе, пљуне или га поврати. Прво треба проверити паковање, рок трајања и прочитати упутство лека. Дати прописану дозу од стране лекара у назначеном временском размаку између две дозе. Придржавати се предвиђеног трајања терапије и упутства током узимања/пре, за време, после јела, итд./Давати лек детету у изворном облику према узрасту детета и тежини коју ординира педијатар. Најбоље је детету објаснити/ако то узраст детета дозвољава/ зашто је потребно да попије лек. За мерење дозе користи се **пластични шприц, градуисана кашичица или капаљка за лекове**. Орални лекови/сирупи/се релативно лако примењују код одојчади због њиховог природног рефлекса сисања и код одојчади испод 4 месеца старости због неразвијеног осећаја за укус. Бебу/дете ставити у наручје и подигнути му главу и рамена или окренути главу на страну због безбедног давања лека и спречавања да дође до загрицавања. Дете држати близу свог тела да би могло да се опружи. Омогућити активном одојчету да заузме положај који му је комфоран. Положити главу бебе на унутрашњу страну лакта своје леве руке. Дланом исте руке кажипрстом и средњим прстом лагано повући угао уста. Тако правимо тзв. цеп у образу. Десном руком врхом шприца капљати/истискивати лек у мањим количинама. У овом положају беба ће лакше прогутати течност, а глава јој се неће померати. **Давање сирупа из чашице** је погодно за дете старије од две године које реагује плачем уколико види шприц или капаљку. У том случају треба капаљком или шприцем одмерити праву дозу и пресути је у чашицу за лек. Ако дете уме да говори питати га да ли може да држи само чашицу да бисмо установили његову сарадњу. Уколико дете поврати целу количину сирупа у року од 5-10 минута од давања истог, треба направити паузу од 30 минута да се смири вагусни надражај у желуцу и поновити целу дозу сирупа. Ако дете поврати и другу дозу, не понављати је опет већ се јавити педијатру! **Ректалне супозиторије** се чувају у фрижидеру да би се спречило њихово размекшавање и могућа смањеност ефикасности лека. Често се примењују код беба/деце уколико дете повраћа, одбија да узме лек/ најчешће за обарање температуре. Ослободити бебу од пелена, односно дете од одеће и на тај начин открити само глутеални део. Левом руком подићи горњи део глутеуса на горе. Кажипрстом десне руке ставити супозиторију, прво заобљени врх, док не осетимо да је прошла анални сфинктер и затим

је лагано утиснути у ректум. Притиснути глутеусе прстима једне руке 5-10 минута након пласирања супозиторије да би се лек правилно растопио под температуром тела и спречило истискивање нагоном за дефекацију. **Капи за очи** се користе у терапијске сврхе код беба и деце. Пре употребе лека коју је преписао лекар, треба проверити дозу односно број капи које треба укапати, да ли у оба или једно око, колико пута у току дана, рок важења утиснут на оригиналном паковању. Тупферима стерилне газе натопљене физиолошким раствором уклонити све нечистоће ока од спољашњег дела ока ка унутрашњем, односно ка корену носа, користећи за сваки покрет нови тупфер газе. Уколико има сасушеног секрета поновити поступак са влажном стерилном газом онолико пута колико је потребно да сасушени секрет постане довољно мек да може да се уклони без оштећења слезнице ока. Бебу/дете ставити у лежећи положај или седећи са благо забаченом главом уназад ако то узраст детета дозвољава. Приликом укапавања капи у око, треба повући доњи капак надолу, да се боље види а и ослободи коњуктивална кеса/унутрашњи простор доњег капка. Укапати прописан број капи у око.

Дојење

Предности дојења

Хумано млеко данас се дефинише као биолошки систем а не само као храна и сматра се медицинским ресурсом. Јединствени састав хуманог млека има незаменљиво место у процесу програмирања здраве људске врсте. “Формула” је само храна, док је хумано млеко комплексна жива хранљива течност која садржи антитела, ензими, хормоне и бројне друге састојке неопходне за правилан раст и развој и доживотно здравље. Дојење је далеко више него једноставно уношење хране. Током дојења успоставља се чврста веза између мајке и бебе и задовољава се бебина потреба за љубављу, топлотом и сигурношћу на јединствен начин.. **ДОЈЕЊЕ ЈЕ ХРАНА И ЗА ДУШУ.** **Предности дојења за бебу**- смањен ризик за настанак различитих болести: инфекција/гастроинтестиналних, упала средњег уха, респираторних које захтевају хоспитализацију/; алергија/астма, атопијски дерматитис;/некротичног ентероколитиса код прематуруса; СИДСа; дечје леукемије; целијакије и инфламаторне болести црева код деце. Правилан развој вилице и говорног апарата. **Предност дојења за мајку**- смањује ризик оболевања мајке од пременопаузалног карцинома дојке, карцинома оваријума и дијабета тип 2 (осим гестацијског). Контрацептивни ефекат током дојења. Мајчино млеко је увек доступно, хигијенски исправно, одговарајуће температуре, бесплатно.

Хигијена и нега дојки

Дојка а посебно брадавица не сме да се пере пре почетка подоја. Хигијена дојки се одржава као и хигијена целог тела, туширањем једном у току дана уз коришћење неутралног сапуна. Пре самог почетка подоја обавезно добро опрати руке топлем водом и сапуном. Затим истиснути неколико капи млека из дојки и премазати брадавице и ареоле како би беба осетила мирис и укус млека. Ако се јави проблем пре подоја, ако су дојке тешке, отечене, набрекле и пуне млека препоручује се комбинација топлих облога и масаже дојки пред подој и измлазање, како би се беби олакшало припајање на дојку. Уколико дојке остану пуне и после подоја, потребно је измлазати млеко из дојке. Након завршеног подоја истиснути неколико капи млека и поново премазати брадавице и ареоле и осушити их на ваздуху. Дојке што чешће излагати ваздуху.

Положаји при дојењу

Најбољи положај за дојење је онај у коме се ви и беба осећате удобно! Бол у леђима, болна епизиотомија (рана од порођаја) или рана од царског реза, могу допринети да се не уклапате у препоручене положаје за дојење. Заузмите положај у коме вас ништа не боли и нежно прислоните бебу на дојку. Седећи положај са бебом у наручју **„Положај колевке“** мама и бебина кичма су под правим углом; бебина глава се налази на прегибу лакта; тело бебе се придржава целом дужином руке; слободном руком нудите дојку. Седећи положај, са бебом у наручју **„Унакрсни положај колевке“** Беба лежи у вашем крилу или на јастуку. Уколико дојите бебу на левој дојци, придржавајте дојку „У“ захватом леве руке, а бебу придржавајте прстима десне руке. Седећи положај, са бебом у наручју **„Хват рагби лопте“** ово је добар положај за маме које су се породиле царским резом. **Лежећи положај**, са бебом која лежи на боку окренута према вама овај положај одговара многим мамама, нарочито ноћу, код епизиотомије је врло практичан.

Правилно постављање бебе на дојку

Мама и беба су активни партнери у дојењу. У првим данима они истражују једно друго, уче једно о другом, упознају се и усклађују из дана у дан. Период адаптације је такође време када се усвајају правилне технике дојења, јер је то важна карика за успешно дојење. Некад се технике науче и савладају за кратак временски период, а неким мамама је потребно више вежбе и труда. Не зависи све од маминог знања и вештине, већ и од бебиног темперамента, понашања и здравственог стања. Мама заузима удобан положај са бебом и полако поставља бебу на дојку. Дојка је близу бебиних уста и треба допустити беби да истражује дојку. Чуло мириса је код беба јако изражено. Покрените рефлекс сисања нежним мажењем бебиних уста брадавицом дојке, можете истиснути кап млека и њом премазати брадавицу. Када беба у потпуности отвори уста (као да зева), брадавицу усмерите ка непцу; брадавица клизи у бебина отворена уста низ горњу усну, а језик је испружен испод брадавице. Дојку све време придржавајте слободном руком како бисте беби олакшали сисање. Бебина брада додирује дојку, доња усна је извијена ка бради, језик је испод брадавице, а нос мало одмакнут од брадавице. Уколико беба није добро постављена, ако осећате бол, прекините дојење, заголицајте бебину доњу усну да лагано испусти дојку, скините бебу са дојке и поновите поступак. Понекад је потребно да додатно припремите дојке за подој (на пример код препуњености дојки).

Испуцале брадавице-рагаде

Повећана осетљивост брадавица се може јавити пред крај трудноће и у првим данима након порођаја на почетку дојења. Најинтензивнија је између 3–6 дана након порођаја. То је нормална и уобичајена појава. Разлог за настанак повећане осетљивости је растезање колагених влакана,

повећана прокрвљеност и понекад оштећена кожа на брадавицама све док се не учврсти кератински слој епитела. Болне и испуцале брадавице могу често довести мајку до суза и бити узрок настанка других потешкоћа везаних за дојење, као и узрок прекида дојења. Узроци који могу довести до болних и испуцалих брадавица: неправилан положај за време подоја; неправилна техника подоја; препуњеност дојки; инфекција брадавица; кратка подјезична везица код бебе. Знаци и симптоми- бол у ареоли или брадавици; после подоја брадавица има гроздаст облик, топла је и црвена, као одрана, крвари; дојка је понекад набрекла, отечена. Уколико оштећено место крвари, ту дојку поштедите од подоја 1-2 дана. За то време, дојку редовно празните ручним измлазањем на 2-3 сата. Дајте беби млеко кашичицом, шољом, шприцем. Брадавице можете премазати и хипоалергеним модификованим ланолином. Избегавајте прање брадавица сапунима, геловима за туширање који додатно исушују брадавице. Можете користити силиконске брадавице и шкољке за груди.

Упала дојки

Разлог зашто, у основи, долази до упале дојке (маститиса) је застој млека. Код маститиса (запаљења дојке) млеко отежано истиче из оболеле дојке, дојка је набрекла, кожа затегнута сјајна, црвена, болна на додир, телесна температура је повишена, а може бити присутна и грозница, вртоглавица, малаксалост, главобоља. Ако се правилно лечи висока температура обично престане у току 24 часа, а бол, црвенило и оток на дојци се полако смањује током неколико дана (3-4 дана). Узроци настајања- неправилно, недовољно често и кратко дојење; епотпуно пражњење дојке дојењем или измлазањем; неправилно пражњени или нелечени блокирани млечни канали; Испуцале брадавице; инфекција која се са брадавица пренесе путем млечних канала у саму дојку; Повећано стварање млека. Поступак неге дојки- Не прекидајте дојење (осим ако прекид није препоручио лекар). Дојење прво из оболеле дојке. Пре подоја на кратко ставите топао облог да би се мало проширили канали и олакшало истицање млека (не дуже од пар минута, јер топло може погоршати упалу). Лагано измасирајте оболели део (притиснути болно подручје, задржати притисак док се бол не умањи, па дланом лагано клизити према брадавици и поновити поступак). После сваког подоја, измлазајте млеко из оболеле дојке. Ставите хладне облоге након измлазања до 15 мин. Користите лагану одећу, грудњак који је за број већи или будите без грудњака.

Измлазање мајчиног млека

У периоду лактације постоје различите ситуације када је измлазање млека корисно, а понекад једино решење. Мама се измлаза како би подстакла, очувала или повећала стварање млека. Најчешћи разлози за измлазање млека Подстицање стварања млека (беба слабије сиса, теже прихвата дојку, превремено рођена беба, беба ниске порођајне тежине, болесна беба, беба има жутицу...); Болне и оштећене брадавице; Блокирани млечни канали; Застој млека; Упала дојке. Одржавање лактације у стањима када је дојење привремено прекинуто; Донирање млека у банку млека. Измлазање може бити ручно или уз помоћ пумпице, и то је вештина која се учи. Ручно измлазање је најстарији и најчешће коришћен метод пражњења дојки. Пре измлазања руке се добро оперу, палцем и кажипрст заузимају положај латинског слова „U“, обухвати се алеола и лаганим покретима ка грудном когу истиска се млеко. Престе померате лагана у правцу казаљке на сату. Поступак је једноставан, практичан, не захтева никакву посебну опрему, само

мамине руке, мало вештине и пуно воље. Измлазање млека уз помоћ пумпице неколико минута пре измлазања млека ставити топле облоге на груди., нежно масирати обе дојке; притиснути мало млека из обе дојке; левак пумпице и силиконску масажну превлаку чврсто притиснути на дојку; полако потиснути ручицу пумпице на доле, задржати пар секунди, па пустити, имитирати ритам сисања.

Чување млека

Чување мајчиног млека започиње поступком измлазања, ручно или помоћу пумпице (ручне или електричне). Пумпице за измлазање су одличне јер се директно млеко накупља у стерилној флашици која иде уз пумпицу, те нема контаминације са спољном средином. Преручити га у специјалне кесице или стерилне посуде (чашице) у количини коју ће беба попити за један оброк, тако га одложити и чувати до употребе. Обавезно уписати на налепници датум и време одлагања млека. Практичније је оставити по мање млека у више посуда. Млеко се може чувати на собној температури – од 3 до 4 сата, уколико је температура просторије од 18 до 24 степена; у фрижидеру – од 24 до 72 сата (посуду са млеком ставити дубље у фрижидер, не у врата где је кретање ваздуха велико); у замрзивачу – од 3 до 4 месеца. Подгревање измлазаног млека- посуду са млеком ставити у посуду са топлом водом или грејач; загрејати само количину за једно храњење; током подгревања млеко се не мућка, само се благо меша кружним покретима; једном подгрејано млеко, више се не подгрева, остатак се баца; млеко се не подгрева директно на плотни или микроталасној пећници.

Адаптирана формула

Адаптирано млеко, формула за бебе, вештачко млеко – све су то називи који се односе на млеко које се бебама даје као дохрана. То је храна за бебе које из неког разлога не сисају или им дојење није довољна храна. Адаптирано млеко је произведено по узору на мајчино млеко и садржи протеине, шећере и масти које се не могу унети на други начин осим уз помоћ млека. Адаптирано млеко се бебама може давати од самог рођења. То се односи на бебе рођене у термину као и на превремено рођене бебу. На тржишту постоји више врста адаптираних формула, али се оне пре свега деле према томе за који узраст су намењене. Почетне формуле за одојчад које су специјално формулисане за одојчад тако да у потпуности задовоље нутритивне потребе током првих шест месеци живота. Прелазне формуле за одојчад за разлику од почетних формула, су тако формулисане, да задовоље нутритивне потребе одојчади старије од шест месеци када одојчад постепено прелази на чврсту храну и представљају главну течну намирницу. За посебне медицинске намене – Поред почетних и прелазних формула стандардног састава, на тржишту постоје и формуле које се убрајају у храну за посебне медицинске намене, односно намењене за исхрану беба са посебним потребама или стањима, као што су превремено рођена одојчад или одојчад са малом телесном тежином на рођењу, бебе с утврђеном алергијом на протеине крављег млека, одојчад са учесталим враћањем желудачног садржаја (бљуцањем), али и у стањима као што су дијареја (проливи) или грче. Формуле на бази сојиног млека. Припрема млечне формуле иде по упутству произвођача. Формуле су прашкасте структуре и растварају се са водом. Вода коју користимо мора се прокувати било да се ради од води са чесме или минералној води. На тржишту постоје и специјалне воде за

припрему млека. Загрејану воду оставимо да се прохлади и након тога сјединимо са млеком и центрифугалним покретима сјединити млеко. На надлактици проверити топлоту млека пре него беба крене да пије. Препорука је да се млеко припрема непосредно пре оброка, количина млека која је остала након оброка се баца, немојте је користити за следећи оброк зато што је она потенцијални терен за развој бактерија. Млеко које остане на цуцли и флашици идеални су за развој бактерија па ваша беба може добити дијареју или инфекцију. Флашицу и дуду обавезно добро оперите након сваке употребе и по могућству једном дневно стерилишите. Након увођења прве формуле, пратите реакције бебе, да ли има неких тегоба или алергијских реакција. Уколико дође до нежељених реакција, тада је потребно променити формулу и узети ону која одговара специфичним потребама ваше бебе.

